Advanced Search

ASKEP - CPPT (APT. GIKA IDFI NUGRAHANI, M. FARM,)

LIST REGISTRASI 15 OCT 2026

RAWAT INAP

Merak

00109480

Nama Pasien

Cari Pasien | Reset

No	Tgl Reg	No RM	Nama	Ruang	No. Reg
1	2026/10/14	00109480	SUNARTI	Merak	020201202600010503001

DATA PRIBADI PASIEN PER 15 OCT 2026

No. Registrasi	**020201202600010503001**	Jenis Kel./Gol.Darah	**Perempuan / TIDAK TAHU**
Tanggal Registrasi	**14-10-2026**	Sub Instalasi/Poli	**Merak**
No. RM / No. Ident	**00109480 / 3402125811630001**	Sub Divisi	**-**
Nama	**SUNARTI**	Kamar/No. Bed	**MERAK 314 / 14A**
Alamat	**JL JANTI KANOMAN RT.7, BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN**	Cara Bayar	**JKN Non PBI**
No. Telp.	**089634090927**	Alergi	**AMOXISILIN DAN AMPISILIN**
Tanggal Lahir	**18-11-1963 (62 th 10 bln 27 hr)**	Alergi Obat	
Agama	**ISLAM**	Nama DPJP	**dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM**

MENU

- **RESUME HISTORY (PROFIL RINGKAS MEDIS)**
- **BERKAS RM**
- **MATRIK HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL RADIOLOGI**
- **HISTORY HASIL PATOLOGI**
- **HISTORY HASIL PEMERIKSAAN LAIN**
- RESUME BILLING SEMENTARA
- ASESMEN AWAL
- PENGKAJIAN DAN ASUHAN GIZI
- ALLOANAMNESIS
- VITAL SIGN
- RPPT & CPPT
- INTEGRATED NOTES
- HASIL PEMERIKSAAN ALAT
  - ECHOCARDIOGRAM REPORT
- REKONSILIASI OBAT
- GAMBAR
- DOKUMEN EKSTERNAL
- ASESMEN PASIEN COVID - 19
- DIAGNOSA
- PLANNING - (P)
  - PROSEDUR ICD9-CM
  - RENCANA TINDAKAN
  - RESEP
  - WO PENUNJANG
  - PENGELOLAAN TRANSFUSI DARAH
  - EDUKASI PASIEN
- LEMBAR KONSULTASI
- JAWABAN KONSULTASI
- LAPORAN OPERASI
- SURAT KETERANGAN SAKIT
- SURAT KETERANGAN

RESUME HISTORY (PROFIL RINGKAS MEDIS)

RAWAT JALAN | RAWAT INAP | GAWAT DARURAT | PENUNJANG | HOMECARE | KONSULTASI ONLINE | Semua Pelayanan

1. 14-10-2026 20:45:04 (Merak) DPJP: dr. RADEN TRIYONO EDHI SULISTIYANTO Sp.PD.,FINASIM

ASESMEN AWAL

Assesment Awal

- **Tanggal Assesment**: 15-10-2026 07:36
- **Riwayat Vaksinasi Covid-19**: **Ya**
- **Keluhan Utama**: Keluhan utama : Muntah berulang, lemas -
- **Riwayat Penyakit Sekarang**: Riwayat penyakit sekarang : Pasien datang dengan keluhan muntah berulang dan lemas yang semakin memberat. Keluhan mual +, muntah + muncul sejak 3 hari SMRS, muntah setiap kali makan dan minum, hari ini muntah >10x. Anak pasien menyampaikan hari sabtu malam (4 hari SMRS) pasien minum susu jahe yang di beli di pinggir jalan, lalu keesokan harinya mulai pusing + nggliyer muter, mual +, muntah +, lemas +, batuk + berdahak putih +, dan berkeringat gobyos setiap hari hingga sore ini. Nafsu makan pasien sangat berkurang karena mual, 2 hari ini hanya minum dan tidak mau makan. Keluhan sesak -, nyeri dada -, nyeri perut -, kelemahan anggota gerak -. Pasien sudah periksa ke UGD RPSAU tgl 11/10/2026, diinjeksi obat dan pulang. Sore ini pasien periksa ke Klinik Pratama Ramadhan dengan keluhan lemas, GDS: 294, dan tensi 90/60, disarankan untuk langsung ke UGD RSPAU. RPD: - HT on tx rutin - DM on tx rutin - Riw. Vertigo + - Post OP Phaco + IOL OS a.i Katarak Komplikata dgn dr. Sri Harto, Sp.M tgl 04/08/2026 - Jantung - RPO: Obat dari UGD RSPAU tgl 11/10/2026 - Becom C 1x1 - Betahistin 3x6 mg - Ibuprofen 2x400 mg Obat rutin Poli dr. Edhie, Sp.PD tgl 09/10/2026 - Amlodipin 1x10 mg - Clopidogrel 1x75 mg - Glimepirid 1x3mg - Metformin 1x500 mg *R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin* Diagnosa - Diagnosa Utama : - VOMITUS PROFUS EC DALAM PELACAKAN - Diagnosa Sekunder 1 : - ANOREXIA GERIATRI - Diagnosa Sekunder 2 : - ISPA - Diagnosa Sekunder 3 : - HT ON TX RUTIN - Diagnosa Sekunder 4 : - DM ON TX RUTIN
- **Riwayat Penyakit Dahulu**: ---
- **Obat-obat yang sering digunakan**: ---
- **Lama Perkiraan Dirawat**: 3 Hari
- **Pemeriksaan Fisik**
  - **Tanda Vital**
    - **Tekanan Darah Sistole**: 125 mmHg
    - **Tekanan Darah Diastole**: 68 mmHg
    - **Frekuensi Nadi**: 80 x/menit
    - **Isi & Tegangan**: cukup
    - **Irama**: reguler
    - **Frekuensi Nafas**: 20 x/menit
    - **Suhu**: 36.5 °C
    - **Tipe & Irama:**: Keluhan utama : Muntah berulang, lemas -
    - **Spo2**: 98 %
  - **Nyeri**
    - **Status Nyeri**: TIDAK
  - **Kepala**: Tidak Ada Kelainan
  - **Leher**: Tidak Ada Kelainan
  - **Perut**
    - **Perut**: Tidak Ada Kelainan
    - **Limpa**: Tidak Ada Kelainan
  - **Extrimitas**
    - **Atas**: Tidak Ada Kelainan
    - **Bawah**: Tidak Ada Kelainan

(http://insti.stream:3000)AKAN ()

- **Anogenitalia**
- **Temuan Fisik Lain**: Tidak Ada Kelainan

Diagnosis: -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan

Masalah: [--

Pemeriksaan Penunjang yang menunjang diagnosis

Hasil Lab: Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49) - Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5) - Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000) - Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan. - SGOT, Hasil: 39U/L (< 35) - SGPT, Hasil: 23U/L (< 34) - Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43) - Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1) - Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.

Hasil Radiologi: Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08) - Pulmo tak tampak kelainan - Besar Cor normal

Hasil Patologi Anatomi: --

Hasil Penunjang Lain: --

PENGKAJIAN DAN ASUHAN GIZI

Riwayat Pemeriksaan Gizi

Ruang / Poli : merak

Tanggal: 2026-10-15

Jam: 09:28

Utama (kali/hari): 3x

Selingan / Ngemil (kali/hari): 2x

Ada alergi terhadap makanan: Tidak

Ada makanan pantangan: Ya

Jika ya, sebutkan pantangan makanannya: Makanan/minuman tinggi glukosa, natrium

Kebiasaan makan berkaitan dengan penyakit: Nafsu makan menurun, recall asupan <80%

Antropometri: BB : 60 kg TB : 156 cm IMT : 24,65 kg/m2 Status Gizi : Normal

Biokimia: Laboratorium Patologi Klinik (15-10-2026 08:19:14) - Glukosa Darah Sewaktu (Stik), Hasil: 208mg/dL (< 200) Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49) - Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5) - Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan. - SGOT, Hasil: 39U/L (< 35) - Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43) - Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)

Fisik dan klinis: Tekanan darah: 149/70mmHg, Suhu tubuh: 36.5C, Denyut nadi: Reguler/92 kali/menit, Nafas: 20 kali/menit, SpO2: 96%, Skor nyeri null : 0

Riwayat Diet
(berdasarkan kebiasaan makan): DM

Riwayat Personal: Diagnosis: - Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan

Diagnosis Gizi: Pembatasan asupan zat gizi Karbohidrat sederhana dan Natrium bd gangguan fungsi endokrin dan Hipertensi dd DM dengan Hiperglikemia (GDS, Hasil: 208mg/dL) , Hipertensi (Tekanan darah: 149/70mmHg)

Intervensi Gizi: DIIT DIABETES MELLITUS RENDAH GARAM Tujuan Diet : Memberikan asupan gizi sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien Terapi diet Bentuk : Makanan Lunak (ML)/BB Jenis diet : DMRG Rute : Oral Kebutuhan E dan zat gizi : E : 1776,64 kkal P : 63,21 g L : 53,13 g KH : 251,24 g (55%) Edukasi : Asupan makan sesuai kebutuhan dan diet pasien (3J) Kolaborasi : Asupan makan, ketepatan diet dan daya terima makan pasien

Rencana Monitoring & Evaluasi: Monev : dilakukan 3H sekali 1. Asupan makan (80-110%) 2. Biokimia (sesuai rujukan normal) 3. Fisik/klinis (sesuai rujukan normal)

Petugas Dietisien/Nutrisionis: Nisrina Andika Naharani, A.Md.Gz

Status Nutrisi Pasien

Status Nutrisi: Normal

Keterangan: IMT : 24,65 kg/m2 Status Gizi : Normal

User Insert: NISRINA ANDIKA NAHARANI A.Md.Gz

Tanggal Insert: 15-10-2026 09:29

Status Verif: Belum Verif

Status Konsul: Tidak Konsul

DIAGNOSA

Diagnosa Utama: R11 - Nausea and vomiting
Diagnosa: Vomitus Profuse ec dalam pelacakan

Diagnosa Sekunder 1: E11.0 - Non-insulin-dependent diabetes mellitus: With coma
Diagnosa: DM dengan Hiperglikemia

Diagnosa Sekunder 2: I10 - Essential (primary) hypertension
Diagnosa: Riw. Hipertensi

Diagnosa Sekunder 3: E87.1 - Hypo-osmolality and hyponatraemia
Diagnosa: Hiponatremia Hipochlorida ringan

Catatan Khusus Dokter:

RESEP

IRJ-261014-84441 tgl 14-10-2026 22:48 oleh Raden Triyono Edhi Sulistiyanto **84441**

- ANTASIDA SYR (1, 3x10) sebelum makan
- METOCLOPRAMIDE INJ (4, 3x1) 06 14 22
- NACL 500 ML INF (2, 0x0)
- NOVOFINE 32G 4MM (1, 0x0)
- NOVORAPID FLEXPEN (1, 3x8) 3x8 ui
- OMEPRAZOLE 40 MG INJ (2, 2x1) 12

(http://insti.stream:3000) AKAN ()

- REBAMIPIDE TAB (1, 3x1) sebelum makan
- SPUIT 3CC NIPRO (4, 0x0)
- SPUIT 5CC NIPRO (3, 0x0)

IRJ-261015-84521 tgl 15-10-2026 07:00 oleh dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM **84521**

- METOCLOPRAMIDE INJ (3, 0x0)
- OMEPRAZOLE 40 MG INJ (2, 0x0)
- REBAMIPIDE TAB (3, 0x0)
- SPUIT 3CC NIPRO (3, 0x0)
- SPUIT 5CC NIPRO (3, 0x0)

EDUKASI PASIEN

15-10-2026 09 NISRINA ANDIKA NAHARANI, A.Md.Gz

Diet dan nutrisi

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: MB DMRG

Konsultasi gizi

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: - Edukasi gizi pasien sesuai dengan dietnya (3J) - Edukasi penyimpanan BM dari luar RS

pengelolaan makanan dari luar rumah sakit

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: Makanan disimpan di tempat tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang

(http://instti.streami:3000)AKAN ()